

Criterios de oclusión funcional óptima

Tema 12 · Basado en Okeson 5.^a ed., Capítulo 5

Okeson define la oclusión funcional óptima no por la morfología ideal de Angle, sino por criterios biomecánicos que minimizan las fuerzas lesivas sobre dientes, periodonto, músculos y ATM. El objetivo clínico es una oclusión que el sistema pueda tolerar sin daño.

1. Posición de cierre: contactos estables y simultáneos

Cuando la mandíbula cierra en relación céntrica (o en una posición muy cercana), debe haber contactos oclusales estables y simultáneos en el mayor número posible de dientes. La fuerza se dirige preferentemente en sentido axial (eje largo del diente).

- Contactos en fosas centrales y cúspides de soporte (vestibulares inferiores, palatinas superiores).
- Evitar contactos en crestas marginales y vertientes que generen vectores laterales.
- Un deslizamiento céntrico pequeño (hasta $\approx 1-1,5$ mm) puede ser aceptable si es suave y no produce interferencias.

2. Guía anterior (protrusiva)

En el movimiento protrusivo, los dientes anteriores (incisivos $\pm$ caninos) deben contactar y producir la **desoclusión inmediata de todos los posteriores**. Así los posteriores quedan protegidos de fuerzas horizontales.

- La guía debe ser suficiente para separar los posteriores en cuanto inicia la protrusión.
- Si hay contactos posteriores en protrusión $\rightarrow$ interferencia protrusiva (lesiva).

3. Guía en lateralidad (función canina o de grupo)

En el movimiento de lateralidad, el lado de trabajo debe desocluir el lado de balance (no trabajo).

- **Función canina (preferida)**: solo el canino del lado de trabajo contacta; el resto se separa.
- **Función de grupo**: varios dientes del lado de trabajo contactan. Aceptable si no hay interferencia de balance.
- **Interferencia de balance** (contacto en el lado de no trabajo): la más lesiva. Debe eliminarse si produce daño.

4. Oclusión mutuamente protegida (síntesis)

Es el nombre que resume el esquema ideal:

- En **cierre (MIC)**: los posteriores reciben la carga y protegen a los anteriores.
- En **excursiones**: los anteriores (guía) protegen a los posteriores de fuerzas laterales.

Sinónimos que puedes encontrar: oclusión orgánica, oclusión mutuamente protegida, oclusión funcional óptima. En este curso usamos **oclusión mutuamente protegida / funcional óptima** (terminología Okeson).

5. Fuerzas: magnitud, dirección, duración, frecuencia

Una fuerza se vuelve lesiva cuando supera la capacidad de adaptación de los tejidos. Okeson insiste en que no basta con "eliminar todas las interferencias": hay que valorar si están produciendo daño.

NO hacer: ajustar oclusión de forma agresiva en un paciente con dolor agudo muscular o articular sin haber controlado primero la inflamación y la hiperactividad muscular. Primero terapia reversible (férula, control de parafunción); después, si persiste, terapia oclusal definitiva.

6. Criterios resumidos (checklist clínico)

Criterio	Qué buscar	Señal de alarma
Cierre en RC/MIC	Contactos múltiples, estables, axiales	Contacto único prematuro que desvía
Protrusiva	Solo anteriores contactan; posteriores desocluidos	Contacto posterior en protrusión
Lateralidad trabajo	Canino o grupo de trabajo; resto separado	Contacto en lado de balance
Dirección de fuerza	Axial sobre posteriores en cierre	Vectores laterales persistentes
Adaptación	Sin dolor, sin facetas patológicas, sin movilidad	Daño pese a “buena” morfología

Relación con Angle y Morris

Una Clase I de Angle no garantiza oclusión funcional óptima. Una Clase de Morris describe desviaciones por obstáculos, pero el diagnóstico y el tratamiento se guían por los criterios de este tema y por la presencia de daño (Okeson).

Referencia: Okeson JP. Tratamiento de Oclusión y Afecciones Temporomandibulares. 5.^a ed. Cap. 5.
 Dr. Miguel Alvarado Avilés · Catedrático · Dentipedia